



*BOMBEIRO: O AMIGO
CERTO
NAS HORAS INCERTAS*



Abordagem técnica:

Aspectos específicos

*2º Ten Ivo Dias dos Reis, 7ª Cia Ind
2026)*

Roteiro

- ✓ Introdução;
- ✓ Dinâmicas na abordagem;
- ✓ Abordagem tática – peculiaridades;
- ✓ Outras instituições na cena;
- ✓ Entrada no ambiente e contenção;
- ✓ Tentante com lesões e suicídio completo;
- ✓ Encerramento da ocorrência;
- ✓ Referências.



Dinâmicas na abordagem

Troca de abordador

- ✓ Exaustão do abordador;
 - Condições climáticas, posição na cena, condições fisiológicas ou psicológicas, conteúdo tenso e intenso para o militar.
 - Importante explicar ao tentante o motivo real de sua saída para evitar interpretações negativas;



Dinâmicas na abordagem

Troca de abordador

- ✓ Perda da confiança.
 - Se o tentante fechar o canal de comunicação após uma conduta do abordador, este deve ser imediatamente substituído.
 - Por exemplo, se o tentante perceber que o abordador mentiu, prometeu e não cumpriu, foi ríspido, não respeitou a zona de aproximação ou o desafiou, o próprio abordador pode ter se tornado um fator de risco.



Dinâmicas na abordagem



Migrando da abordagem técnica para a abordagem tática

- ✓ Observar:
 - se há contato visual contínuo;
 - se a entonação da voz é normal;
 - se a postura corporal indica interesse na comunicação;
 - se usa as mãos ou pernas para se prender em algum objeto (revelando ausência de interesse naquele instante de suicidar-se);
 - se consegue falar sobre os fatores de proteção.

Neste caso, há vínculo de confiança com o tentante e o abordador deve permanecer na abordagem técnica;

Dinâmicas na abordagem

Migrando da abordagem técnica para a abordagem tática

- Observar se o tentante percebeu algum ato que possa quebrar o vínculo por parte do abordador;
- Após a quebra de vínculo, observar se há mudanças comportamentais do tentante de forma desproporcional e abrupta;
- Tentante intensifica o foco atencional aos fatores de risco, com quebra de vínculo, com qualquer comportamento que sinalize suicídio iminente, neste instante é dada a voz de comando para a abordagem tática;



Dinâmicas na abordagem

Migrando da abordagem técnica para a abordagem tática

- Não esperar o tentante desprender-se da estrutura em que estiver para ativar a abordagem tática;
- Sempre que se inicia a abordagem técnica, e ocorre quebra do vínculo, deve-se ativar a abordagem tática.

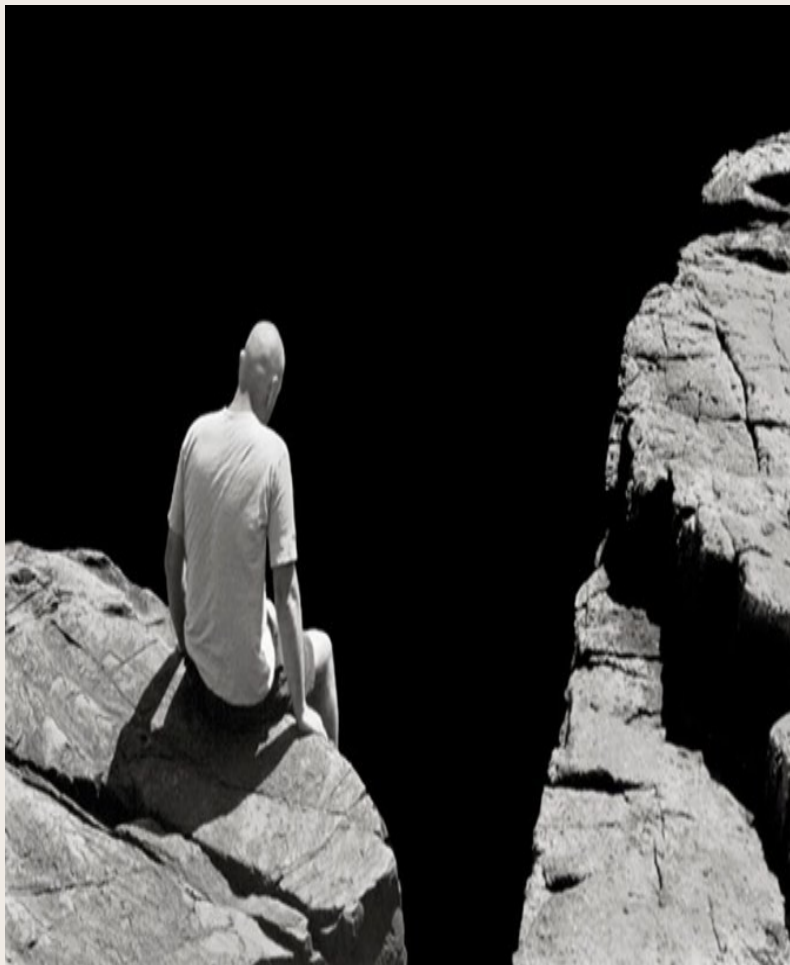


Abordagem tática - peculiaridades



- Uso da força física de contenção do tentante (imobilização, derrubada, paralisação, etc.) com o objetivo de se evitar o suicídio completo.
- Utilizada quando a abordagem técnica falhar
- Quando houver sinais indicativos de suicídio iminente;
- Último recurso empregado, dados os seus riscos inerentes aos envolvidos
- Padronização prévia, de uma palavra e gesto para se acionar a abordagem tática.

Abordagem tática



Risco de precipitação em queda livre

- ✓ Conforme doutrina de salvamento em altura do CBMMG em vigor;
- ✓ Viadutos (análise dos riscos e benefícios): caminhões, ônibus, etc.
- ✓ Abordadores táticos (delimitadores)
- ✓ Em nenhuma hipótese, escalar uma torre de transmissão de eletricidade se o tentante estiver próximo aos cabos elétricos e não houver garantia de que estão desligados;
- ✓ A abordagem tática é o *backup* da abordagem técnica, portanto, será o último recurso, na iminência de suicídio.

Abordagem tática

Risco de afogamento

- ✓ Conforme doutrina de salvamento aquático do CBMMG em vigor;
- ✓ A linha de esforço será: alcançar, lançar, caminhar (locais rasos), remar e **por último, nadar**;
- ✓ O arremesso de flutuadores em direção à vítima, para que esta possa agarrar-se e ser resgatada do ambiente aquático (recomendada);
- ✓ Na água: pelo menos 02 bombeiros militares;
- ✓ as ações de APH para casos de afogamento: ITO 23.



Abordagem tática

Risco de enforcamento

- ✓ Anteparo para suportar o peso do tentante até que a corda seja cortada;
- ✓ Utilizar uma **tesoura**, **faca** ou **canivete** para **cortar a corda** (ou outro instrumento utilizado para enforcamento). Este será o foco na abordagem tática;
- ✓ A equipe de ação **tática** ficará à **retaguarda** da equipe de abordagem técnica, verificando qual é o meio mais rápido e eficaz de chegar ao tentante no caso de acionamento.



Abordagem tática

Tentativa de suicídio por armas brancas

- ✓ Acionar o policiamento para apoio na segurança da Gu BM e da cena em geral;
- ✓ Estabelecer a **rota de fuga** antes da abordagem técnica;
- ✓ O abordador deve permanecer **protegido** por um **anteparo**;
- ✓ A equipe de abordagem tática **atua junto** com a equipe de abordagem técnica, a fim de protegê-la, devidamente equipados com o EPI da atividade;
- ✓ Esguicho com jato compacto em direção ao tentante a fim de neutralizá-lo e retirar a arma branca (**quando possível!!!**).



Abordagem tática

Tentante com intoxicação exógena

- ✓ Se o tentante estiver trancado, considerar a **entrada forçada**;
- ✓ Atentar para o risco do tentante saltar pela janela e a ocorrência virar uma tentativa de suicídio por precipitação.



Abordagem tática

Tentante com arma de fogo

- É de responsabilidade da PMMG;
- Potencial natureza homicídio-suicídio;
- Isolamento do perímetro para evitar possíveis outras vítimas;
- Um abordador BM poderá assessorar as equipes PM
- Guarnição BM devem estar protegidas por um anteparo



Outras instituições na cena



- ✓ Interlocutor já presente na cena **COM** vínculo: orientações verbais de forma discreta;
- ✓ Interlocutor já presente na cena **SEM** vínculo: troca deste interlocutor;
- ✓ **Arma de fogo**: órgãos competentes;
- ✓ SAV/SBV na cena: orientar o melhor posicionamento da ambulância;
- ✓ Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Agentes de Trânsito ou Guardas Municipais na cena: isolamento do local/ manutenção/interrupção do fluxo de trânsito.

Outras instituições na cena

- ✓ Acatar sugestões se não contrariar diretrizes da ITO/ de fato necessárias;
- ✓ Orientação conflituosa/ prejudica o desenvolvimento, o comandante da operação o informará que tal ação não será realizada;
- ✓ Conflito: COBOM/SOU/SOF e solicitar intervenção do CBU, se o tempo total de cena o permitir;



Entrada forçada no ambiente e contenção

Entrada forçada

- ✓ Abordador deve persuadir o tentante: **contato visual**/aumenta aos poucos;
- ✓ Sem comunicação: antes de qualquer entrada tática, **bater à porta**/janela onde está o tentante e de forma enérgica e audível, dizer que irá **contar até 3** (três);
- ✓ Se o tentante não responder, a equipe presumirá que há um risco maior e que será necessário **entrar de forma forçada** no recinto;
- ✓ Após a contagem em voz alta até 3 (três), na ausência de respostas por parte do tentante, a equipe de abordagem tática deverá adentrar o recinto utilizando técnicas de entrada forçada;



Entrada forçada no ambiente e contenção

Entrada forçada

- ✓ Risco: tentante inconsciente, em PR ou PCR decorrente do método utilizado (intoxicação exógena, lesões autoprovocadas com hemorragia, enforcamento, etc.);
- ✓ Checar estabilidade da estrutura antes de entrar;
- ✓ Checar se portas estão abertas, antes de forçá-las;
- ✓ Checar atmosfera explosiva com risco de *backdraft*;
- ✓ Segurança quando estiver quebrando vidros e providenciar a remoção para local adequado;



Entrada forçada no ambiente e contenção



Entrada forçada

- ✓ **Atenção!!!** Possível fuga do tentante por uma janela, transformando a ocorrência em tentativa de **suicídio por precipitação**;
- ✓ Animais de guarda no interior do imóvel e tomar as precauções de segurança;
- ✓ Pode-se adentrar em uma residência sem o consentimento do morador, nos casos específicos de desastre ou para prestar socorro, situações legalmente admitidas pela Constituição Federal.

Entrada forçada no ambiente e contenção

Contenção

- ✓ Física (manual), mecânica (ataduras, tirantes, etc.) e farmacológica (antipsicóticos típicos, atípicos e benzodiazepínicos): CBMMG apenas as duas primeiras;
- ✓ Contenção: tentativa de suicídio interrompido (quebra do canal de comunicação ou risco iminente de suicídio);
- ✓ Contenção física: princípios da ética/respeito à integridade e à dignidade humana/preservação máxima de segurança (do tentante, dos militares da Gu BM e de possíveis terceiros à cena), por meio de profissionais habilitados para tal (como em casos de salvamento em altura ou de incêndios);



Entrada forçada no ambiente e contenção

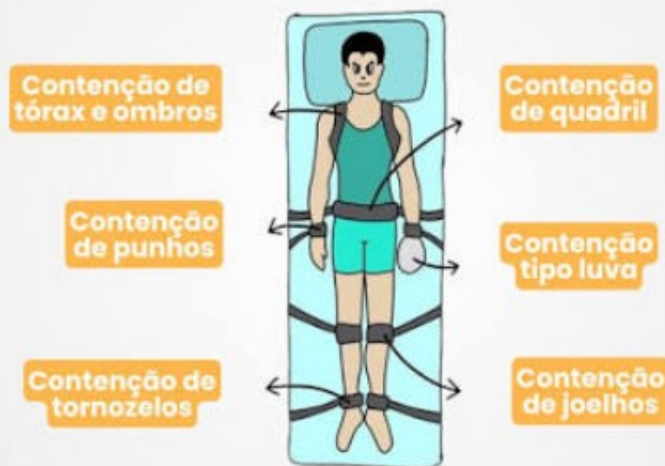
Contenção

- ✓ **Contenção mecânica:** essa deverá ser utilizada somente se for o único meio disponível para **prevenir dano imediato** ou **iminente** ao tentante ou aos demais;
- ✓ **Atenção!!!** Vedado aos militares do CBMMG o emprego de contenção mecânica de tentantes com o propósito de **disciplina, punição e coerção**;
- ✓ Todo tentante em contenção mecânica deve ser monitorado atentamente pela Gu BM, para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou para identificá-los precocemente durante todo o transporte;



Entrada forçada no ambiente e contenção

Contenção Mecânica



Contenção

- ✓ Contraindicações/restrições: tentantes calmos e colaborativos; tentantes agitados ou confusos, mas responsivos aos manejos verbal e tentantes com restrições físicas na região a ser contida;
- ✓ Contenção mecânica: compressas, ataduras, tirantes da prancha-longa, lençóis e a própria prancha-longa (se necessário e viável).

Entrada forçada no ambiente e contenção

Contenção farmacológica

- ✓ Contenção farmacológica (psicotrópicos); integridade do tentante, equipes e terceiros;
- ✓ **Apenas as equipes de saúde**, com médico e equipe de enfermagem na cena **podem medicar** o tentante;
- ✓ Em hipótese alguma, o bombeiro militar do CBMMG poderá aplicar qualquer medicamento em qualquer tentante, sob qualquer circunstância;



Entrada forçada no ambiente e contenção



Contenção farmacológica

- ✓ Gu BM promover a contenção manual e/ou mecânica para que a equipe de saúde possa proceder à contenção farmacológica, quando necessário;
- ✓ A condução do tentante será feita, obrigatoriamente, pela equipe que o medicou, ou esta acompanhará a Gu BM, com os devidos medicamentos/instrumentos necessários para sanar possível efeito colateral ou reação adversa do psicotrópico utilizado.

Tentante com lesões e suicídio completo

Lesões

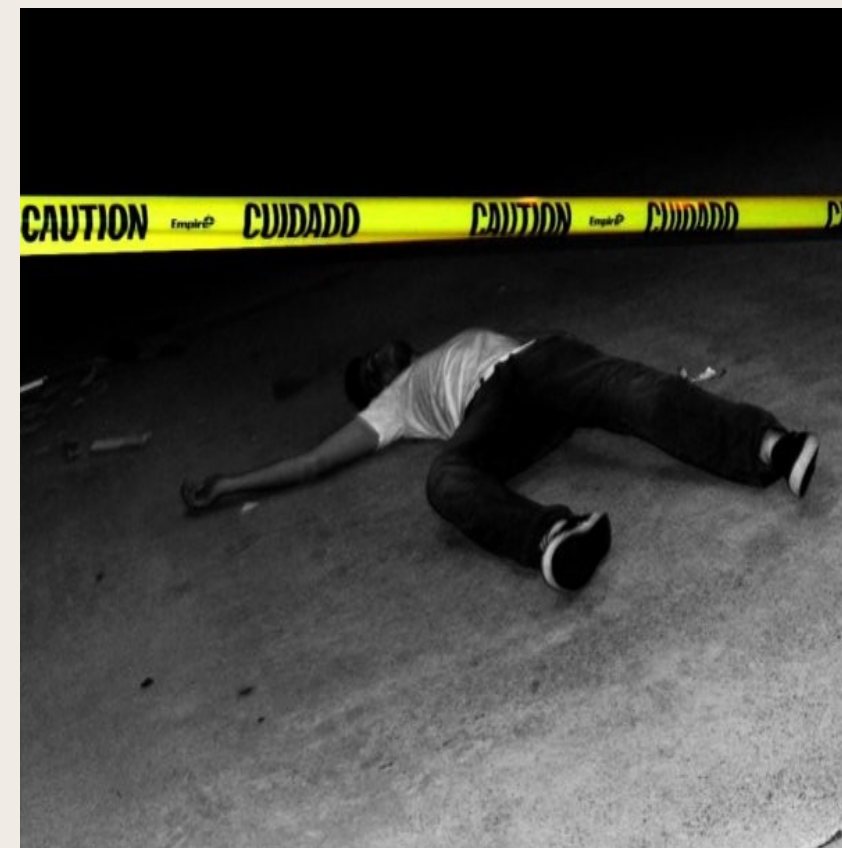
- ✓ Procedimentos de APH do CBMMG em vigor (ITO N° 23);



Tentante com lesões e suicídio completo

Suicídio completo

- ✓ Acionar a perícia técnica;
- ✓ Isolar o local (preservar o possível local de crime)/
Exceção: necessidade de preservar a vida de outrem;
- ✓ Cadáver (considerar a presunção de óbito conforme ITO Nr 23 do CBMMG): não tocar, nem remover da posição original, não revirar os bolsos das vestes e não realizar sua identificação – atribuição essa de responsabilidade da perícia criminal – salvo se houver a efetiva necessidade de preservá-lo materialmente;



Tentante com lesões e suicídio completo

Suicídio completo

- ✓ Não recolher pertences/não mexer nos instrumentos do crime, principalmente armas;
- ✓ Não manusear ou remover veículo/objeto de crime ou utilizado para fuga;
- ✓ Manter portas, janelas, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios, tais como foram encontrados, não os abrindo ou fechando, não os ligando ou desligando, salvo o estritamente necessário para conter riscos eventualmente existentes;
- ✓ Não usar o telefone, sanitário ou lavatório eventualmente existentes;
- ✓ Afastar os animais soltos, principalmente onde houver cadáver;
- ✓ Não expor a vítima com produção de imagens e divulgação em meio virtual.

Encerramento da ocorrência

- ✓ Tentante conduzido independentemente de desfecho (abordagem técnica ou tática). Condução sempre com o respeito e com a ética + Saída honrosa;
- ✓ Acompanhamento do abordador (técnico x tático x preservação);
- ✓ Perícia técnica (óbito no local);
- ✓ Varredura do local (corpos ou pessoas feridas, perigo de Incêndio/explosão, colapso de estruturas etc.);
- ✓ Codificação do REDS adequada: autoextermínio (suicídio) A03000; Vítima de Suicídio (Tentativa) – APH Trauma V03.021; Vítima de Suicídio (Tentativa) – APH Clínico V01.024 e Salvamento Altura Suicídio (S03.015);

Encerramento da ocorrência

- ✓ Ofício à Secretaria Municipal de Saúde do município onde houve a tentativa/suicídio completo para monitoramento e balizamento de possíveis políticas públicas de prevenção e controle da saúde mental no município;
- ✓ Tentativas de suicídio: REDS para Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)/reincidência;
- ✓ Não oferecer dados específicos da ocorrência à imprensa (Efeito *Werther*);
- ✓ Suicídio completo: CBU/Chefe de serviço produz relatório x encaminhar ao NAIS (TEPT/Posvenção);

Fim

**VOCÊ NÃO PRECISA
SOFRER SOZINHO**

Obrigado



Referências

MUNHOZ, Diógenes Martins. **Proposta de Capacitação ao Efetivo do Corpo de Bombeiros para Atendimento a Ocorrências de tentativas de Suicídio**. Monografia do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. 2016.

BOTEGA, N. J. **Crise Suicida**: Avaliação e manejo. 1ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 302 p.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Associação Brasileira de Psiquiatria. **SUICÍDIO**: informando para prevenir. 1ª. ed. Brasília: Portal Print Gráfica e Editora, 2014. 52 p.

DALGALARRONDO, Paulo. **Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais**. 3º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 505 p.

QUEVEDO, J.; CARVALHO, A. F. **Emergências Psiquiátricas**. 3º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 333 p.

QUEVEDO, J.; IZQUIERDO, I. **Neurobiologia dos transtornos psiquiátricos**. 1º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. 392 p.

Referências

MARBACK, R.F.; PELISOLI, C. **Terapia cognitivo-comportamental no manejo da desesperança e pensamentos suicidas**. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, Rio de Janeiro, v. 10, ed. 2, p. 122-129, 17 dez. 2014.

MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ofício nº. 34/2020 - CBMMG/CINDS. **Dados de Registros de Vítimas e de ocorrências relacionadas a suicídio atendidas pelo CBMMG**, Belo Horizonte: EMBM2, ano 2020, 18 jul. 2020.

_____. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Instrução Técnica Operacional n.30: **Atendimento a Tentativas de Suicídio**. 1ª ed. Belo Horizonte: CBMMG, 2021.

WENZEL, Amy; BROWN, GREGORY K.; BECK, Aaron T. **Terapia cognitivo-comportamental para pacientes suicidas**. Porto Alegre: Artmed, 2010. 304 p.